

5 人に 1 人は、
希望と違う場所で亡くなっている

20%

緩和ケア病棟を経由した患者 — 最も手厚い支援を受けた集団においてさえ

あなたが担当した患者さんは、希望通りの場所で最期を迎えられましたか？

今日の学習目標

解釈（理解）

ACP の看取り場所一致率データを
国際比較の中で解釈できる

分析

不一致が生じる構造的要因を 3 つ以上挙げ、
因果関係を分析できる

創造

在宅看取りの意思決定支援計画を
自分の臨床に合わせて立案できる

ブルーム分類：理解 → 分析 → 創造

ACP（アドバンス・ケア・プランニング）の基本概念

概念	定義	ポイント
ACP	本人を中心に繰り返し話し合い、意思決定を支援するプロセス	紙ではなくプロセス
AD（事前指示書）	意思決定能力喪失時の法的文書	ACPの一部であって ACP そのものではない
一致率	事前合意と実際の死亡場所が一致した割合	place-of-death congruence

ACPは「紙に書くこと」ではなく「対話のプロセス」—— 2018年「人生会議」啓発以降、認知は向上したが実践の質にはばらつきあり

本研究のデザインと対象

項目	内容
著者	佐藤桃香ほか（東北大学大学院 緩和ケア看護学分野）
デザイン	多施設遺族調査（後ろ向き横断研究）の付帯研究、2018 年実施
対象	ホスピス・緩和ケア病棟から自宅退院→その後死亡した終末期がん患者の遺族 359 名
自宅死亡群	遺族 202 名
病棟死亡群	遺族 157 名
測定	看取り方針（事前合意） vs 実際の看取り場所の一致・不一致 + 不一致理由

メソドロジの限界：想起バイアス・生存者バイアス・選択バイアスに留意

一致率 80-82% — この数字をどう読むか

自宅死亡

80%

n=202

緩和ケア病棟死亡

82%

n=157

「ACP は概ね機能する」——しかし 5 人に 1 人は希望と異なる場所で死を迎えている。
最も手厚い支援を受けた集団での数値であることに注目。

国際メタアナリシスとの比較

地域 / 対象	一致率	出典
メタアナリシス統合値	約 51%	Billari et al., 2022
南アフリカ	48%	95%CI: 41-55%
マレーシア	92%	95%CI: 88-95%
本研究（自宅死亡）	80%	佐藤ほか，2026
本研究（病棟死亡）	82%	佐藤ほか，2026

上位の理由：緩和ケア病棟を経由 → 専門的 ACP の実施率が高い母集団。
一般的な在宅療養患者ではさらに高い不一致率が想定される。

なぜ不一致が起きるのか — 構造的要因の分析

病棟方針 → 自宅看取り（22 例）

ポジティブな変更
在宅対応の医師・看護師が見つかり、
より本人の希望に近い方向へ

自宅方針 → 病棟看取り（11 例）

ネガティブな変更
自宅での痛み管理が不十分で、
在宅医療の質的限界が原因

医師偏在

2040 年に約 170 自治体で
内科診療所ゼロの推計
24 時間対応の物理的困難

痛み管理格差

在宅ではオピオイド持続皮下注等
の専門スキル不足
家族の介護負担の限界

教育格差

介護職向け緩和ケア教育
は約 10% のみ
アウトリーチ活動 9.3%

ケース：「自宅で最期まで」が叶わなかった A さん

70 代男性、進行膵がん。緩和ケア病棟で症状安定後、ACP で「自宅で最期を」と合意し退院。
退院 2 週間後、夜間の突然の激しい腹痛。妻がパニックで 119 番通報。
救急搬送 → 緩和ケア病棟に再入院 → 5 日後に病棟で死亡。

ディスカッション（ペアまたは 3 人グループ、3 分）

1. このケースで不一致を防げたポイントはどこか？
2. 退院前に、どのような「仕組み」があればよかったか？
3. 家族（妻）にどのような事前準備ができたか？

Phase 1-4 のトランジション設計で何ができたか？

Phase	タイミング	Aさんのケースでの具体策
1	入院後 72 時間以内	ACP 開始、在宅資源アセスメント
2	在宅準備期	家族への疼痛管理教育、レスキュー薬の事前配置、24 時間連絡先の確認
3	退院後 48 時間以内	訪問診療医初回訪問、家族の不安への対応
4	在宅療養期	定期的な方針再確認（ACP の反復）、バックアップベッドの確保

ACP は「一度やれば終わり」ではなく、トランジションごとに再確認・再調整するプロセス。

振り返りと、明日からの臨床への問い

1

一致率 80-82% は国際的に上位だが、
「5 人に 1 人」の不一致は構造的課題が原因

2

不一致は「医師偏在」「痛み管理格差」
「教育格差」の 3 層で生じている

3

ACP は「紙の文書」ではなく
「繰り返しの対話プロセス」として機能させる

持ち帰りの問い

「あなたの診療圏で、在宅看取りを阻んでいる最大の構造的障壁は何ですか？」
「次に看取りに関わるとき、ACP の再確認をどのタイミングで行いますか？」